

WEEKLY REPORT



小編：伊君

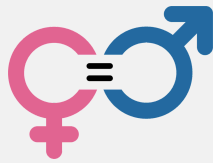
教學中心 & 實證醫學暨醫療政策中心週戰報

FRIENDLINESS



友善

EQUALITY



平等

ART



藝術

INSIGHT



洞察力

世代差異中隱藏著組織改革的契機

韌性，如同一股隱形卻有力的潮流，正逐漸滲透進我們的世界中。醫療領域對韌性的定義：指個人或組織面對壓力、危機或困境時，能有效調適、快速恢復，甚至從挑戰中學習並成長的能力。不同世代的醫護人員，因為各自成長於不同環境中，所建構的韌性內涵也有所差異。戰後嬰兒潮與X世代，強調「忍耐、承受壓力與艱苦耐勞」，他們將韌性視為堅忍不拔、逆境中堅守的毅力；而Y、Z世代，則將韌性理解為「保持彈性、主動適應與積極尋求支持」，強調能快速反應與積極恢復狀態的能力。這種多元且世代交織的韌性，正是醫療組織面臨轉型與挑戰時，能否融合差異、共同前進的關鍵所在。

世代間的韌性差異，在醫療現場往往導致許多認知衝突。例如，主管認為加班超時、工作壓力大是訓練年輕人韌性的必要過程，但年輕醫護人員則認為過勞與過度忍耐，並非真正的韌性，反而可能導致身心耗竭，這種衝突在許多醫療機構屢見不鮮。雙方的認知落差與對韌性定義的不同，形成醫療環境中跨世代溝通的障礙。

然而，衝突本身正提供了醫療體系建立跨世代韌性共識的契機。醫療機構若能從衝突的背後看見雙方價值觀的差異，並刻意促進對話與交流，便能有機會跨過藩籬。例如，可以推動「韌性共學計畫」：將資深醫護人員與新進醫護人員組成跨世代配對，共同討論壓力應對方式。年輕一代透過資深者的經驗，學會在緊急醫療事故中保持穩定情緒及有效應對策略；資深前輩則從年輕同仁身上，學習利用數位工具與資源，快速處理病人諮詢，並建立自我照護的韌性技巧。這樣的共學，不僅能促進跨世代理解，更能提升團隊整體的韌性。

又如許多醫院在疫情期間設立心理支持小組，鼓勵各世代共同參與，透過專業輔導與同儕支持，協助醫護人員調適壓力，避免過度耗竭。這樣的作法使各世代不再排斥，反而視之為維持韌性與醫療品質的重要環節。

當真誠對話發生，不同世代的理解得以交流，當韌性意涵能相互體會，便能引領社會邁向更加和諧與共創的未來。社會、企業、甚至家庭的永續發展，都仰賴著這種跨世代的韌性結合。我們若不再強求單一種模式，而是允許不同的韌性並存與交織，形成兼具堅毅、彈性與創新的共同文化。透過這樣的融合，不同世代將共同書寫出屬於這個世代對韌性的新意義，也才能跨越時代的差異，進而互相合作，邁向充滿共識與希望的未來。

A-LINE置放訓練

臨床技能中心正式推動A-LINE（動脈導管）置放訓練課程，旨在提升住院醫師急重症處置能力。此項高頻率使用且具風險的技能，已成為現代醫師的核心能力。



有別於傳統「邊做邊學」的學習模式，本課程採「知識+技術」雙軌設計，結合模擬設備與分站練習，讓年輕醫師在安全環境中熟練技術，建立信心。

自3/20至5/12期間，中心針對五大部門共118位住院醫師規劃25場訓練，目前已有97位完成，涵蓋率達82.2%。

職場性騷擾防治

本次演講由嘉南藥理大學社工系助理教授江承曉老師主講，主題聚焦於性平三法修正對醫療職場性騷擾防治帶來的影響及應注意事項。演講強調在 ME TOO 浪潮下，臺灣性平法規的變革，並呼籲建立以「被害人保護為中心」的職場環境。

法規適用範圍(請認真筆記)

法規適用主要依據事件發生場域及當事人身分區分：

- 病人對醫護人員的性騷擾適用**性騷擾防治法**
- 同事間的性騷擾適用**性別平等工作法**
- 醫護人員利用權勢對病人或受指導者的性騷擾，屬權勢性騷擾，將**加重裁罰**

醫院責任與義務

雇主（醫院）責任在新法下大幅強化：

- 須落實預防與防治工作，包含宣導、教育訓練及設置申訴管道
- 知悉性騷擾情事時（無論是否正式申訴）必須立即處理並通報相關單位
- 主動提供被害人協助，包括醫療、心理、法律等支援，即使被害人拒絕也需留下紀錄
- 進行公正調查並對行為人實施適當懲處



同仁應對建議：

- 提高個人性別意識，相信自己的直覺判斷
- 面對不當行為時明確表達拒絕
- 遇到問題時尋求協助並提出申訴
- 蒐集相關證據以協助後續調查

治本之策：脊髓性肌肉萎縮症精準治療的新突破

高雄醫學大學前校長鐘育志教授闡述了脊髓性肌肉萎縮症(SMA)治療的突破性進展，他回顧了自己投入研究這個曾被視為蠻荒領域的罕見疾病的歷程，從早期診斷困難的時代到現今多元治療方法的發展。



治療突破與早期干預的重要性

近年來，SMA 治療取得重大突破，已有三種獲FDA核准的疾病緩解藥物，包括 **RNA藥物**、**基因治療**和**口服藥物**。多項嚴謹的臨床試驗證實了這些藥物的顯著療效。研究中發現一個關鍵因素：**越早治療效果越好**，特別是在症狀出現前進行治療的預後，遠優於症狀發作後才開始治療的情況。

臺灣在SMA防治的領先地位

臺灣在SMA防治方面的發展歷程令人欽佩，從早期專注於基礎研究與藥物研發，逐漸轉向重視病人照護與積極參與國際臨床試驗。2021年，臺灣被認定為全球唯一實施全國性新生兒SMA篩檢並為確診個案提供藥物治療的國家。同時，健保自2020年起分階段納入SMA藥物給付，且持續放寬給付條件。這些努力已顯著提升許多病友的生活品質，扭轉了疾病的宿命。



未來展望與持續努力的方向

儘管已取得重大進展，鐘教授指出仍有努力空間。他呼籲將SMA新生兒篩檢納入公費項目，以提高篩檢率至100%。同時，他強調應為具有潛在快速進展風險 (SMN2基因拷貝數 ≤ 3) 的個案提供 儘早(症狀前)治療。展望未來，治療概念甚至可能延伸至產前階段。鐘教授分享，他持續投入這個領域的動力來自與病友的互動學習，以及見證他們面對困境時展現的樂觀態度和不退縮的精神。最後，他引用名言強調：**衡量一個社會道德水準的標準，在於它如何對待最弱勢的兒童群體。**

醫學研究的跨域合作與倫理使命

鐘教授強調科學探索與轉譯醫學的道路充滿挑戰，需要投入巨大勇氣、時間和跨領域合作。成功的關鍵在於整合產業、政府、學術界及研究機構的力量，同時秉持無私利他的胸懷。他指出，精準醫療的核心價值在於考量個體差異，為每位病人制定最適合的治療與預防策略。

SMA的疾病特性與全人照護

脊髓性肌肉萎縮症是一種嚴重的單基因遺傳疾病，曾是導致嬰兒死亡率最高的遺傳性疾病之一。其致病機轉與 SMN1基因突變 及 SMN2基因拷貝數密切相關。在藥物研發的漫長等待期間，鐘教授強調跨領域的全人照護對提升病友生活品質相當重要，為此他積極投入病友協會的建立，為病人提供全面的資源與支持。

破繭而出

分享者：教學中心淑雅

大阪萬國博覽會：一場探索未來設計的文化之旅

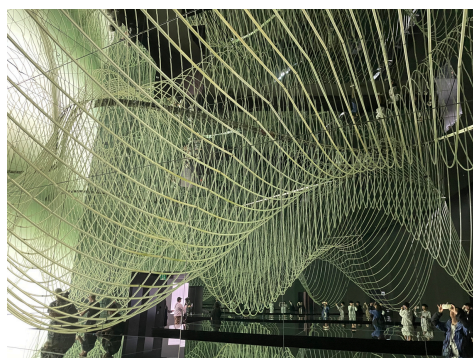
博覽會場地遼闊，宛如踏入另一個時空，來自世界各地的人潮匯聚於此，彷彿人類文明的一場盛大集結。其中最具有象徵性的地標**大屋根環**，巧妙融合自然意象與建築美學，象徵著永續與循環的理念。夜晚登頂遠眺，大阪港的摩天輪與徐徐晚風交織成詩，無人機在夜空中劃出和平與祝福的圖樣，為這場文化盛會點亮對未來的希望。

各國展館如文化萬花筒，有的展現歷史傳承，有的擘畫科技未來，共同訴說各自的文化願景與未來想像。

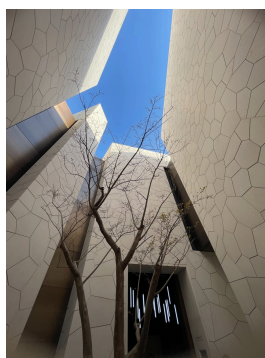
日本館的策展令人讚歎，不僅有極致細膩的視覺呈現，更蘊含哲學深度。展館以「生命的未來」為主題，從再生能源、醫療科技到社會福祉，呈現日本社會對少子高齡化挑戰的積極回應。**沙烏地阿拉伯館**以金屬與曲線堆疊出的建築語彙，搭配沉浸式投影技術，展示其未來願景與文化驕傲。



大屋根環



日本館



沙烏地阿拉伯館

PASONA NATUREVERSE 展出前瞻的醫療藍圖：從空中手術室到 **IPS 細胞再生器官**，結合 AI 與物聯網技術，解析未來醫療將如何跳脫時空的束縛。

臺灣科技館雖隱含政治因素而未能正名展場，但其中的內容令國人捧腹卻又耐人尋味地方式展現本土創意與科技底蘊，讓許多國人駐足莞爾。

大阪萬博不只是展覽，更是一場關於未來的深刻對話，讓我重新思考生活的本質，並激發行動的勇氣。從選擇環保的飲食與交通方式，到主動學習人工智慧與數位技能，都能在日常實踐永續與創新。生活就是創作的舞台，美感與創意不再只是藝術家的專利，而是每個人都能實踐的態度與選擇。



IPS 細胞再生器官



臺灣科技館

美國作家 - 拿破侖·希爾

THE TURNING POINT IN THE LIVES OF
THOSE WHO SUCCEED USUALLY COMES AT
THE MOMENT OF SOME CRISIS - THROUGH
WHICH THEY ARE INTRODUCED TO THEIR
OTHER SELVES.

成功者的人生轉捩點，通常都
是在某危機時刻——藉由那危
機，他們認識了另一個自己。